ความก้าวหน้า ไม่ได้เกิดขึ้นเอง

แพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2556–2568 แต่ประชาชนแต่ละพื้นที่ยังมีคนให้บริการสุขภาพไม่เท่ากัน ความก้าวหน้าจึงต้องวัดทั้งจำนวนคนและการกระจาย รัฐต้องจัดตำแหน่ง งบจ้าง และทีมให้พื้นที่ที่ยังขาด

> **“ตำแหน่งที่รัฐกำหนดคือรูปธรรมของการระบุความรับผิดชอบของรัฐกับพันธะต่อประชาชนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า”**
>
> จากรายงานผลการวิจัย

■ 8 จังหวัดสีชมพู ได้แก่ บึงกาฬ, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, กำแพงเพชร, อำนาจเจริญ, ยโสธร, เลย, สกลนคร อยู่ในกลุ่ม 19 จังหวัดที่อัตราส่วนแพทย์กระทรวงสาธารณสุขต่ำสุดทุกเกณฑ์ ทั้งต่อประชากร ปริมาณบริการสุขภาพ การใช้บริการที่ปรับด้วยแบบจำลองให้เทียบกันได้ และปีสุขภาพดีที่สูญเสียจากโรค

45,937
แพทย์ทั้งรัฐและเอกชนใน พ.ศ. 2568
เพิ่มจาก 26,767 คนใน พ.ศ. 2556

8
จังหวัดที่แพทย์น้อยทุกเกณฑ์
แพทย์เทียบกับประชากรและงานตามแผนที่ด้านบน

43.7%
ของเป้าแพทย์ที่ 19 จังหวัดที่ขาดที่สุดจะมีใน พ.ศ. 2583 ถ้าเพิ่มตำแหน่งให้ที่ขาดก่อน
เป้าตัวอย่างคือแพทย์ต่อประชากร 1:1,000 ถ้าเพิ่มตามสัดส่วนเดิมจะได้ร้อยละ 39.0

16%
คิดออกจากราชการหรือสังกัดในสามปี
ผลสำรวจถ่วงน้ำหนัก ผู้ตอบ 734 คนใน 66 จังหวัด

หมอเพิ่มแล้ว ทำไมบางพื้นที่ยังขาด

ทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศึกษาว่าการเพิ่มบุคลากรช่วยให้ประชาชนมีบริการสุขภาพเพียงพอได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จำนวนคน งานบริการสุขภาพ และความเจ็บป่วย จำลองการจัดสรรแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ 76 จังหวัดตามตำแหน่งข้าราชการที่มีงบจ้าง และสำรวจคนทำงาน ผลชี้ว่าต้องพิจารณาทั้งพื้นที่ที่จะเพิ่มตำแหน่งและเงื่อนไขที่ช่วยให้คนทำงานอยู่ต่อ

ในฉบับนี้

1 ห้าข้อค้นพบ หมอเพิ่มแล้ว เหตุใดยังขาด
2 ข้อเสนอเจ็ดข้อที่ต้องทำเป็นชุด
3 สี่คำถามที่สังคมต้องร่วมตัดสิน
4 แบบจำลองใช้ตัดสินใจได้แค่ไหน

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ข้อเสนอเจ็ดข้อที่ต้องทำเป็นชุด

ข้อเสนอทั้งเจ็ดต้องทำไปด้วยกัน เพราะถ้าข้อใดไม่เกิด ข้ออื่นจะได้ผลน้อยลงแม้ใช้ทรัพยากรไปแล้ว

1. **นับบุคลากรให้ตรงกันก่อนแบ่งคน**
   เจ้าของข้อมูลและผู้วางแผนต้องตกลงว่าจะนับวิชาชีพใด สังกัดใด และพื้นที่ใด แล้วตรวจยอดให้ตรงกัน เพื่อไม่ให้จัดคนจากตัวเลขคนละชุด
2. **ใช้เกณฑ์เดียวกันเปรียบเทียบทุกแผน**
   ผู้วางแผนควรเปิดผลว่าแผนใดช่วยพื้นที่ขาดได้เท่าใด ความต่างระหว่างจังหวัดลดหรือไม่ และพื้นที่ใดได้คนเพิ่มหรือน้อยลง
3. **ทบทวนตำแหน่งทุกห้าปี เน้นพื้นที่ขาด**
   ทุกห้าปีให้ตัดสินว่าจะเพิ่มตำแหน่งและงบที่ใด ให้ผู้จ่ายเงินวางตำแหน่งตามจำนวนแพทย์ที่ขาด โดยให้พื้นที่ที่มีแพทย์ต่อประชากรน้อยได้ก่อน แล้วจัดแพทย์ใหม่ทุกปีตามตำแหน่งที่ว่างจริง พร้อมเตรียมทีมและที่ทำงาน
4. **วางแผนฝึกแพทย์คู่กับงานที่จะรองรับ**
   ผู้จัดการศึกษาและกระทรวงควรวางแผนตำแหน่งรับผู้จบและผู้กลับจากฝึกเฉพาะทาง จำนวนรับในแบบจำลองคือผู้ตอบรับเริ่มงาน ไม่ใช่จำนวนบัณฑิต
5. **ช่วยให้คนอยู่ต่อด้วยการแก้ปัญหางาน**
   ผู้จ้างควรเริ่มจากพื้นที่ทุรกันดารและงานจ้างไม่มั่นคง เสริมทีม โอกาสฝึก และการยอมรับ พร้อมแก้ค่าตอบแทน จำนวนคน และภาระงานควบคู่กัน
6. **พัฒนาบริการสุขภาพโดยนับภาระของครอบครัวด้วย**
   หน่วยบริการสุขภาพควรติดตามงานที่ครอบครัวและบุคลากรต้องรับเพิ่มเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน เพื่อไม่ให้ผลประหยัดซ่อนต้นทุนของผู้ดูแล
7. **ทบทวนทุกปี เปิดเหตุผลให้ตรวจสอบ**
   ผู้วางแผนควรปรับรายชื่อพื้นที่สำคัญทุกปี ประกาศเกณฑ์ก่อนประเมิน และเปิดให้ประชาชนกับผู้ปฏิบัติงานทักท้วงด้วยหลักฐาน

สี่คำถามที่สังคมต้องร่วมตัดสิน

ตัวเลขบอกผลและทรัพยากรที่แต่ละทางเลือกต้องใช้ แต่ประชาชนและผู้รับผิดชอบต้องร่วมกันเลือก

1 ควรเพิ่มคนตามจำนวนผู้มารักษา หรือความเจ็บป่วยของประชาชน

2 ส่วนกลางหรือโรงพยาบาลควรเป็นผู้จ่ายค่าจ้าง หากต้องการบุคลากรมากกว่ากรอบที่ตั้งไว้ และพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมด้านใด

3 เมื่อคนไม่พอ ใครต้องรับงานเพิ่ม: บุคลากรหรือครอบครัว

4 ใครร่วมกำหนดได้ว่าคนและบริการสุขภาพเท่าใดจึงพอ และจะตกลงร่วมกันอย่างไร

แบบจำลองใช้ตัดสินใจได้แค่ไหน

- ✓ ผ่านด้านจำนวนคน: แบบจำลองคาดจำนวนแพทย์รายจังหวัดล่วงหน้าสามปี คลาดจากข้อมูลจริงเฉลี่ย 28.1 คน น้อยกว่าการเดาว่าจำนวนจะเท่าเดิม ซึ่งคลาด 33.3 คน
- × ไม่ผ่านด้านช่วงคาดการณ์: ค่าจริงอยู่นอกช่วงจำนวนแพทย์ที่แบบจำลองคาดไว้บ่อยเกินเกณฑ์
- × ไม่ผ่านด้านพื้นที่: รายชื่อ 19 จังหวัดที่แพทย์เทียบเป้าต่ำสุดตรงกับรายชื่อจากข้อมูลจริงน้อยกว่าเกณฑ์

คณะวิจัยกำหนดเกณฑ์ทั้งสามก่อนทดสอบกับข้อมูลอดีต แบบจำลองจึงใช้เปรียบเทียบทางเลือกและทรัพยากรที่ต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันได้ ส่วนรายชื่อจังหวัดที่ควรได้คนเพิ่มต้องทบทวนทุกปี ไม่ควรยึดตายตัว

ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรได้บ้าง

- เป้าแพทย์ต่อประชากร 1:1,000 ที่กระทรวงรับผิดชอบ เป็นตัวอย่างสำหรับเทียบแผน ไม่ใช่มาตรฐานกระทรวง
- ผลสำรวจถ่วงน้ำหนักตามกลุ่มบุคลากร บอกความตั้งใจ ไม่ใช่การออกจริง และไม่ได้สำรวจผู้ที่ออกไปแล้ว
- ข้อมูลรับเข้าและออกนับครั้งที่เกิดเหตุการณ์ คนเดิมอาจถูกนับหลายครั้ง
- บริการคาดหมายมาตรฐานคือการใช้บริการสุขภาพที่แบบจำลองปรับให้เทียบกันได้ ไม่ใช่จำนวนผู้จำเป็นต้องรักษา

อ่านผล ทดลองแผน ดาวน์โหลดข้อมูล

สแกนรหัสหรือเปิดเว็บไซต์เพื่ออ่านวิธีศึกษา กราฟ และข้อมูล ในส่วนทดลองจัดสรรกำลังคน (Workforce Lab) คุณเปลี่ยนกติกาการเพิ่มตำแหน่งและดูผลต่อแต่ละพื้นที่ได้

psitthirat.github.io/HRH-model

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานผลการวิจัยโครงการการพัฒนาแนวทางและนโยบายการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพโดยใช้แบบจำลองแบบบูรณาการ (ตุลาคม 2569).

หมอเพิ่มแล้ว เหตุใดยังขาด

การศึกษาครั้งนี้ดูจำนวนบุคลากร งานที่รับผิดชอบ ตำแหน่งที่จ้างได้ และชีวิตคนทำงาน

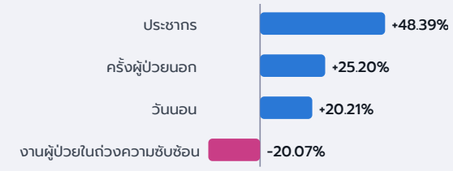
ข้อค้นพบที่ 1

หมอพอไหม ต้องบอกว่าเทียบกับอะไร

แพทย์กระทรวงสาธารณสุขกลุ่มเดียวกันให้ภาพต่างกันตามสิ่งที่นำมาเทียบ แพทย์ต่อประชากรเพิ่มร้อยละ 48.39 ระหว่าง พ.ศ. 2556–2568 แต่เมื่อให้น้ำหนักผู้ป่วยที่รักษายากมากกว่า แพทย์ต่องานผู้ป่วยในลดลงร้อยละ 20.07 ระหว่างปีงบประมาณ 2561–2568 ส่วนหนึ่งเพราะระบบจัดกลุ่มโรคเปลี่ยน หมอเพิ่มจึงยังไม่แปลว่าทันงาน

-20.07% แพทย์กระทรวงสาธารณสุขต่องานผู้ป่วยในที่ให้น้ำหนักตามความซับซ้อน ปีงบประมาณ 2561–2568

แพทย์กระทรวงสาธารณสุขเทียบกับคนและงาน เปลี่ยนไปร้อยละเท่าใด



ร้อยละที่เปลี่ยนของแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อแต่ละสิ่งที่นำมาเทียบ พ.ศ. 2556–2568 ยกเว้นงานผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561–2568

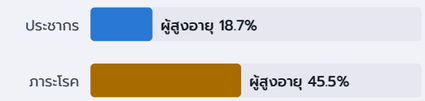
ข้อค้นพบที่ 2

จังหวัดที่ป่วยมากมักมีแพทย์น้อย

คนอายุหกสิบปีขึ้นไปมีร้อยละ 18.7 ของประชากร แต่รับภาระโรคร้อยละ 45.5 ภาระโรคคือปีสุขภาพดีที่เสียไปจากการเจ็บป่วยและการตายก่อนวัย แพทย์ทั้งรัฐและเอกชนกลับอยู่มากในจังหวัดที่ภาระโรคต่ำ แผนเพิ่มคนจึงต้องดูความเจ็บป่วย ไม่ใช่แค่จำนวนครั้งที่มารักษา ซึ่งไม่นับคนที่เข้าไม่ถึงบริการ

45.5% ของภาระโรคอยู่กับผู้สูงอายุ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 18.7 ของประชากร

ผู้สูงอายุ: สัดส่วนประชากรเทียบสัดส่วนภาระโรค



ผู้สูงอายุคืออายุหกสิบปีขึ้นไป ภาระโรคจากการศึกษาภาระโรค ค.ศ. 2022

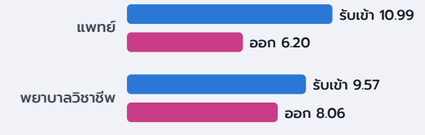
ข้อค้นพบที่ 3

คนยังกระจุกตัว และรับใหม่เพื่อทดแทน

สัดส่วนแพทย์เฉพาะทางในสถานพยาบาลหนึ่งในสิบที่มีมากที่สุดเพิ่มจากร้อยละ 61.6 เป็น 63.5 ระหว่าง พ.ศ. 2564–2567 (เฉพาะแห่งที่มีแพทย์เฉพาะทาง ทั้งรัฐและเอกชน) แม้บรรจุครบตำแหน่ง แพทย์กระทรวงสาธารณสุขต่อประชากรต่างกัน 3.4 เท่าระหว่างจังหวัดสูงสุดกับต่ำสุด พยาบาลที่รับใหม่ส่วนใหญ่ทดแทนคนที่ออก การผลิตเพิ่มอย่างเดียวจึงไม่พอ

8 ใน 10 ของพยาบาลวิชาชีพที่รับเข้าใหม่ไปแทนคนที่ออก จึงเพิ่มขึ้นจริงเพียงราว 2 ใน 10

เหตุการณ์รับเข้าและออก ต่อบุคลากรร้อยคนต่อปี



เหตุการณ์ต่อบุคลากรร้อยคนต่อปี ปีงบประมาณ 2560–2568 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ช่องว่างขยายตัวเองได้ และแคบลงได้ด้วยนโยบาย

พื้นที่ที่ได้เปรียบมักดึงคน เงิน และโอกาสเพิ่มเป็นวงจร ช่องว่างจึงกว้างขึ้นเองถ้าไม่มีใครแก้ Gunnar Myrdal นักเศรษฐศาสตร์ชาวสวีเดน เรียกว่าเหตุปัจจัยแบบวนและสะสม ไทยเคยทำให้ช่องว่างแคบลงในช่วงที่รัฐให้แพทย์ใช้ทุนและขยายโรงพยาบาลชนบท แม้ยังแยกไม่ได้ว่านโยบายใดเป็นสาเหตุ แต่วันนี้กลับกว้างขึ้น จาก 4.3 เท่าใน พ.ศ. 2556 เป็น 5.7 เท่าใน พ.ศ. 2568

กรุงเทพฯ มีแพทย์ต่อประชากรเป็นกี่เท่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ค.ศ. 1979–1996: Wibulpolprasert และ Pengpaibon (2003) บันทึกเชิงพรรณนา · ค.ศ. 2013 และ 2025: การศึกษาครั้งนี้ แพทย์ทุกสังกัดต่อประชากรทะเบียนราษฎร ต่างแหล่งจากชุดเดิม เทียบได้เพียงขนาด

ความก้าวหน้าไม่ได้เกิดขึ้นเอง

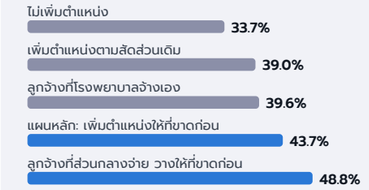
ข้อค้นพบที่ 4

เพิ่มหมอต้องมีตำแหน่งว่างให้บรรจุ

แพทย์ใหม่ในกระทรวงสาธารณสุขบรรจุได้เฉพาะในตำแหน่งที่มีงบจ้างและยังว่าง แบบจำลองจึงทดลองกติกาเพิ่มตำแหน่งไปถึง พ.ศ. 2583 ถ้าไม่เพิ่มเลย แพทย์ใหม่ 5,442 คนจะไม่มีตำแหน่งรองรับ ต้องจ้างแบบอื่นหรือออกจากระบบ และเมื่อตำแหน่งเต็ม ไม่ว่าใช้สูตรใดแบ่งแพทย์ใหม่ จังหวัดที่ขาดก็ได้เท่ากัน เพราะแบ่งได้แค่ตำแหน่งที่ว่าง คำถามจึงอยู่ที่ว่าจะเพิ่มตำแหน่งที่ใด การเพิ่มให้จังหวัดที่ขาดก่อนได้ผลมากกว่าการเพิ่มตามสัดส่วนตำแหน่งที่มีอยู่เดิม ถ้าจ้างเป็นลูกจ้าง ผู้จ่ายก็สำคัญ หากโรงพยาบาลจ้างเองจำนวนลูกจ้างขึ้นกับรายได้โรงพยาบาล ส่วนลูกจ้างที่ส่วนกลางจ่ายและวางให้ที่ขาดก่อนได้ผลมากที่สุด ถ้าอยู่นานเท่าข้าราชการ ทั้งหมดเป็นผลจากการทำแบบจำลองเท่านั้น

2.0 เท่า ของตำแหน่งที่แผนหลักเพิ่ม หากเพิ่มตามสัดส่วนเดิมเพื่อให้จังหวัดที่ขาดได้ผลเท่ากัน

ร้อยละของเป้าแพทย์ที่ 19 จังหวัดต่ำสุดจะมีใน พ.ศ. 2583 ตามกติกาจ้าง



ร้อยละของเป้าตัวอย่างแพทย์ต่อประชากร 1:1,000 ที่กระทรวงรับผิดชอบ ซึ่งไม่ใช่มาตรฐานของกระทรวง กลุ่มล่างคือ 19 จังหวัดที่ห่างเป้ามากที่สุด

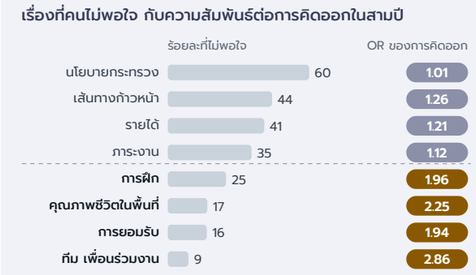
ข้อค้นพบที่ 5

ความไม่พอใจเรื่องใดมาพร้อมกับการคิดออก

การสำรวจคนทำงานด้านสุขภาพ 734 คน ระหว่างกรกฎาคม–ตุลาคม 2569 พบว่าร้อยละ 16 คิดจะออกจากราชการหรือสังกัดภายในสามปี มีผู้ไม่พอใจนโยบายกำลังคนของกระทรวงและรายได้มาก แต่เมื่อเทียบผู้ตอบในวิชาชีพและระดับหน่วยบริการเดียวกัน สองเรื่องนี้ไม่ได้มาพร้อมกับการคิดออกอย่างชัดเจน เรื่องที่มาพร้อมกันคือความไม่พอใจต่อทีม ชีวิตในพื้นที่ โอกาสฝึก และการยอมรับ ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถระบุสาเหตุได้

2.86 เท่า OR ของการคิดออกในผู้ที่ไม่พอใจทีมและเพื่อนร่วมงาน เทียบผู้ที่พอใจ ส่วนเรื่องรายได้อยู่ที่ 1.21 เท่า

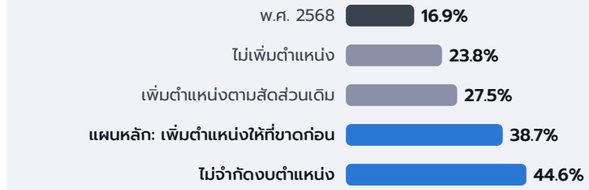
เรื่องที่คนไม่พอใจ กับความสัมพันธ์ต่อการคิดออกในสามปี



OR เทียบโอกาสคิดออกของผู้ไม่พอใจเรื่องนั้นกับผู้ที่พอใจ สีทองคือเรื่องที่สัมพันธ์กับการคิดออกอย่างชัดเจน

บึงกาฬภายใต้กติกาตำแหน่งต่างกัน

บึงกาฬต่ำที่สุดในทุกเกณฑ์ มีแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 72 คน ตำแหน่งที่มีงบจ้าง 137 ตำแหน่ง และแพทย์ออกปีละร้อยละ 13.4 กราฟเทียบค่าใน พ.ศ. 2568 กับผลจำลองใน พ.ศ. 2583 ทุกกติกายังไม่ถึงเป้า แต่กติกาตำแหน่งทำให้ผลต่างกันมาก



ร้อยละของเป้าตัวอย่างแพทย์ต่อประชากร 1:1,000 ที่กระทรวงรับผิดชอบ เป็นผลจากการทำแบบจำลองเท่านั้น

ตัวเลขดีขึ้นได้สามทาง

1. เพิ่มคน เวลา และเครื่องมือให้บริการสุขภาพ
2. ลดเป้าหมาย เช่น ไม่นับประชาชนบางกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบ
3. งานยังอยู่ แต่ให้ครอบครัวหรือวิชาชีพอื่นรับภาระแทน

เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านเร็ว ครอบครัวอาจต้องจัดยาและเฝ้าอาการ ผู้ตอบสำรวจร้อยละ 43 เป็นผู้ดูแลหลักที่บ้านด้วย จึงควรนับภาระของคนทำงานและครอบครัว